

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	腸胃道出血的照護 Gastrointestinal Bleeding；GI Bleeding				
編號	A31000-Q03-W-D08	制定者	N08 李昀臻	公布日期	106 年 05 月 10 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	112 年 11 月 21 日
版本/總頁數	第 1.5 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 02 日

一、目的

讓護理人員了解腸胃道出血的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

由食道到肛門之間任何一部位發生出血情形，都稱之腸胃道出血。

（二）症狀

1. 吐血：(1)鮮紅色為發生出血的時間短；(2)暗紅色為發生出血的時間長，血液已與胃酸充分混合血紅素轉變成棕色的黑質所造成。常見為上消化道出血造成。
2. 黑便或血便：通常要有 60cc 的血液且積留在腸胃道 6~8 小時，才會出現黑便；若積留時間不足，則會呈現暗紅色或鮮紅色的血便。一般為下消化道出血造成，但有 10%以上大量及快速出血時也可能以血便表現。
3. 低血量休克徵象：當血液流失達 1,500~2,000cc，病人會出現意識混亂、躁動、不安、低血壓、心搏過快、脈搏減弱、皮膚濕冷與蒼白等症狀。
4. 腸蠕動：過速代表可能發生上腸胃道出血、蠕動正常或不足則可能為下腸胃道出血。
5. 腹痛、呼吸困難、無力、疲倦、胸前區灼熱感、體重減輕。

主題名稱	腸胃道出血的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D08	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	2/7

6. 其他如黃疸、腹水等。

(三) 常見檢查

1. 實驗室檢查：

(1)血中尿素氮(BUN)與肌酸酐(creatinine)：於出血後 24~48 小時升高。

(2)血液檢查：血紅素、血比容值於出血後 6 小時開始降低；白血球數值可能升高；因胃黏膜損傷引起；肝功能檢查數值升高、凝血因子減少，凝血酶原時間(PT)降至正常時間的一半。

(3)動脈血液氣體分析：剛開始為呼吸性鹼中毒，之後呈現代謝性酸中毒。

2. 腸胃科相關檢查與治療：

(1)內視鏡檢查：

A. 胃鏡檢查：診斷的正確性高且可以合併止血。

B. 大腸鏡和乙狀結腸鏡檢查。

(2)血管攝影：找到出血部位後可於動脈內滴注血管加壓劑或行動脈栓塞術，使出血停止。

(四) 常見治療

依個人病情，在治療上有所不同，分為手術治療與非手術治療：

1. 外科手術治療：適合手術的狀況，包含(1)病人因失血導致輸血量超過 2,500cc；

(2)病人輸血量每天至少 1,500cc，才能維持穩定的生命徵象時；(3)老年人併發胃潰瘍出血。

2. 非手術治療：

(1) 栓塞療法：以血管攝影找到出血部位後，再注入硬化劑，使血管硬化減少出血。

(2) 滴注血管加壓素(Vasopressin)：劑量依出血程度而定，須以靜脈輸液幫浦控制給藥。

(3) 輸血：當出現低血壓或心搏過速時，需輸注全血；當出現慢性出血，則補充濃縮紅血球，直到血壓、心跳恢復正常由醫師評估是否停止輸血。

主題名稱	腸胃道出血的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D08	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	3/7

(4) 治療性內視鏡治療：原理為利用熱以凝固出血點達到止血目的。

(5) 鼻胃管灌洗：每 30~45 分鐘灌洗一次，每次以溫水或生理食鹽水灌洗 50~100cc，灌入後留置數分鐘再排出，目的在使胃鏡檢查時視野不會受干擾。

(五) 護理問題

1. 易受傷害：出血／和有效血流量減少有關。
2. 體液容積不足：出血／和有效血流量減少有關。
3. 疼痛不適／與胃黏膜受破壞有關。
4. 焦慮感受／與健康狀態改變有關。

(六) 護理措施

1. 易受傷害：出血／和有效血流量減少有關。
 - (1) 監測生命徵象及密切評估出血徵象，如吐血、便血，每班評估是否有臉色蒼白、頭暈、冒冷汗、脈搏變快情形。
 - (2) 急性期應依醫囑禁食，若有血色素偏低情形，應注意下床安全性或採臥床休息，以避免跌倒的危險。
 - (3) 依醫囑給予輸血治療。
 - (4) 依醫囑給予抑制胃酸分泌藥物，如：氫離子幫浦抑制劑(proton pump inhibitors, PPI)與 H₂ antagonists 兩大類，以 PPI 藥物效果較佳。
 - (5) 在醫師評估下，應避免使用抗凝血劑、NSAID 止痛藥及水楊酸類藥物，並應注意部分止痛藥物可能增加出血的風險。
 - (6) 教導勿提重物或用力解便，避免腹壓上升。
 - (7) 給予飲食衛教單張並強調避免如糙米、麻辣鍋、羊肉爐、熱湯等食物，食物宜放冷後再食用。
 - (8) 教導喝果汁、牛奶等流質飲食二天，之後改採軟質飲食如稀飯、咀嚼易碎食物，並避免粗糙、堅硬、酥脆及油炸食物。
 - (9) 鼓勵病人表達其情緒與需求，並耐心傾聽，提供照護相關訊息及心理支持。

主題名稱	腸胃道出血的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D08	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	4/7

(10)密切監測血液報告，如 Hb，Hct，PT，PTT 及血小板計數的檢驗數據等。

2.體液容積不足：出血／和有效血流量減少有關。

- (1)監測生命徵象、意識狀態及有無休克症狀。
- (2)評估皮膚的溫度及顏色。
- (3)觀察、記錄出血量及出血情形，並告知醫師。
- (4)絕對臥床休息，避免暈眩造成意外。
- (5)鼓勵家屬陪伴，給予心理支持。
- (6)依醫囑予補充液體或血液，並記錄輸出入量。

3.疼痛不適／與胃黏膜受破壞有關。

- (1)注意觀察生命徵象。
- (2)評估疼痛部位、特性、時間、頻率、性質、強度或嚴重度。
- (3)對於無法有效地溝通之病人，應觀察病人不舒適的非語言動作或表情。
- (4)選擇疼痛緩解措施時，須考慮疼痛的型態及位置。
- (5)依醫囑給予適合之止痛藥，緩解疼痛。
- (6)評估止痛藥之效果及有無副作用，以確認病人有接受適當之止痛照護。
- (7)鼓勵多休息，並採舒適臥姿以減輕疼痛。
- (8)衛教應避免劇烈的身體活動，以降低胃分泌及蠕動。
- (9)鼓勵家屬陪伴及參與，可以轉移病人注意力，如聊天、聽音樂，減輕疼痛的主觀感受。

4.焦慮感受／與健康狀態改變有關。

- (1)評估病人焦慮程度及主要原因。
- (2)請醫師解釋病人疾病進展與治療過程，並協助確認病人的壓力來源。
- (3)向病人解釋各項檢查與治療的目的與重要性，以減少焦慮。
- (4)常給予探視並表示關懷，增加安全感，減少焦慮。
- (5)恐懼感持續無法改善，必要時依醫囑給予鎮靜藥物治療。
- (6)利用行為或認知策略，教導病人規律的呼吸、放鬆的技巧及冥想來減輕恐懼。

主題名稱	腸胃道出血的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D08	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	5/7

(7)安排病人喜歡的環境，分散注意力，減輕恐懼，例如：聽音樂、聊天。

(8)鼓勵家屬多給予陪伴並給予心理支持。

(七) 衛教指導

- 1.採軟質飲食，應細嚼慢嚥，勿食用過硬、粗糙、過熱及刺激性（酒、咖啡、香料、酸、辣）、易產氣之食物，以免刺激腸胃道造成出血。
- 2.避免工作過於疲累，每天應有一定的休息時間及睡眠，飯後應有短時間的休息。
- 3.注意出血徵兆如:臉色蒼白、呼吸急促、心跳加快、煩躁、不安、解黑便及嘔血，應立即到醫院求治。
- 4.依醫囑按時服藥，定時門診追蹤。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 官泰全、藍苑慈(2020)・下消化道出血・*臨床醫學月刊*，85(3)，135-139。

[https://doi.org/10.6666/ClinMed.202003_85\(3\).0025](https://doi.org/10.6666/ClinMed.202003_85(3).0025)

(二) Wilkins, T., Wheeler, B., & Carpenter, M.(2020). Upper gastrointestinal bleeding in adults: Evaluation and management. *American Family Physician*, 101(5), 294-300.

七、附件

(略)

主題名稱	腸胃道出血的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D08	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
106.05.10	1.0	新制定。	106 年 05 月 10 日護理部照護標準委員會通過；106 年 05 月 10 日公布。
107.06.29	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	1.1	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第四目之 2(3)(5)；第六目之 1(4)(5)說明內容部份修訂。 3. 第六項參考資料修訂。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。
107.12.13	1.2	1. 第三項第三目之 2(1)；第四目之 2(3)說明內容文字部份修訂。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	107 年 12 月 13 日照護標準組會議通過； 108 年 01 月 09 日護理長會議通過；108 年 01 月 22 日督導會議通過公布。
108.09.23	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
109.08.18	1.3	第六項參考資料修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.10.07	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	1.4	1. 第三項第五、六目之護理問題修訂。 2. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。

